HELP_Organi_P01 — Critique — 17 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 1 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

A-007 — Critique — LOT 1 · SSP G1

Emplacement : LOT_1_Appel_B_V4_Argon_Expert_Complet__export_GoogleDoc.html › Partie 3 › D1.6 › point 11.B › patient inconscient ; constats L1-M43, L1-M21, L1-M20, L1-M14

Contexte : La V4 donne au patient inconscient un volume de glucose n'apportant que 8–10 g ; la V6 ne donne ni dose, ni voie, ni spécialité. L'audit s'appuie sur le guide britannique JBDS-IP 2018 (75–100 mL de glucose 20 % en 15 min, ou glucagon 1 mg IM, GlucaGen®, Baqsimi® 3 mg) et sur l'IHSG 2017 (< 3,0 mmol/L) ; le cours cite l'ADA 2026.

Question : Quelle recommandation suisse (SSED/SGED, protocole d'un hôpital universitaire suisse) ou européenne la plus récente fixe la conduite devant une hypoglycémie sévère de l'adulte : quantité de glucose en grammes, concentration et volume, vitesse, glucagon IM/SC ou nasal, contrôle et répétition, seuils de définition (niveaux 1–3) ? Quelles spécialités sont autorisées en Suisse (GlucaGen® HypoKit, Baqsimi®, Ogluo®, glucose 10/20/40/50 %) et quelle est leur dose adulte et pédiatrique selon l'AIPS ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-021 — Critique — LOT 2 · SSP G2

Emplacement : LOT_2_Appel_B_V4_Argon_Partie_4_D2.8_a_D2.10__export_GoogleDoc.html › D2.10 › point 14 Pièges ; constats L2-M31, L2-L49

Contexte : Le point 14 associe la dose prophylactique du cotrimoxazole (Bactrim® forte 800/160 mg, 1 cp/j ou 3×/semaine) au « traitement » de la pneumocystose ; l'audit cite EACS (TMP 5 mg/kg + SMX 25 mg/kg 3×/j ≥ 21 jours).

Question : Quelles sont, selon la version la plus récente des guidelines EACS et l'AIPS suisse de Bactrim®, la prophylaxie primaire de la pneumocystose (seuil de CD4, dose, arrêt) et le traitement curatif (dose par kg, rythme, durée, voie, adaptation rénale, corticothérapie selon la PaO2) ? Existe-t-il une recommandation suisse (SSI, Cohorte VIH suisse) qui diffère ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-026 — Critique — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D3.1 › 11. Prise en charge › 11.B. Moyens ; constats L3-M11, L3-L21, L3-L55, L3-L27, L3-L29

Contexte : La V5 a perdu le seuil de kaliémie (« Si : ») et donne un débit de KCl de 20–40 mmol/h ; la V6 écrit « hypokaliémie importante » sans seuil ; le seuil d'osmolalité de l'EHH diffère entre V5 (320 efficace) et V6 (300 efficace/320 totale) ; une spécialité citée en D3.1 › 11.D n'a pas de statut Swissmedic. L'audit cite le consensus 2024 ADA/EASD/JBDS (KCl 10 mmol/h).

Question : Quel protocole de prise en charge de l'acidocétose diabétique et de l'état hyperglycémique hyperosmolaire recommande la source européenne la plus récente (consensus 2024 EASD/JBDS, protocole SSED ou d'un hôpital universitaire suisse) : remplissage, seuils de kaliémie avant insuline, débit maximal de KCl par voie périphérique et centrale, insuline (débit, voie), ajout de glucose, critères diagnostiques (pH, bicarbonate, osmolalité efficace et totale) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-028 — Critique — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D3.4 › 9. Examens › fenêtre « Consulter la hiérarchie des examens » › 2e intention ; constats L3-M13, L3-M36, L3-L31, L5-M19, L5-M20, L5-L50, L5-L51, L5-M26

Contexte : LOT_3 (D3.4) limite le bolus de NaCl 3 % à une répétition et vise 4–6 mmol/L ; LOT_5 (D5.4, fenêtre 3.4 et point 11.B.1) donne 100 mL en 10 min dans le tableau et 150 mL en 20 min au point 11.B, un objectif de 1–2 mmol/L/h, une classification fausse et une conduite sous thiazidique non sourcée. Le texte intégral de l'ESE/ESICM/ERBP 2014 n'a pas été lu (résumés secondaires).

Question : Que recommande exactement la recommandation européenne sur l'hyponatrémie (Spasovski 2014) et toute mise à jour postérieure (ESE, ERA, consensus 2023–2025, essai SALSA) pour l'hyponatrémie symptomatique sévère et modérée : volume et concentration du bolus, durée, nombre de répétitions, objectif de la première heure, limites à 24 et 48 h, classification (légère, modérée, profonde), conduite en cas de surcorrection, cas particulier de l'hyponatrémie aux thiazidiques ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-029 — Critique — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D3.7 › 11. Prise en charge › 11.B. Moyens ; constats L3-M14, L3-M45, L3-M46, L3-M53, L3-L39, L3-L25, L5-M25, L5-M24

Contexte : La V6 n'a aucun traitement de l'hypercalcémie ; la V5 propose le dénosumab 60 mg chez l'insuffisant rénal sévère, une calcitonine selon la notice américaine et une contre-indication du zolédronate < 35 mL/min (ostéoporose) ; les seuils de calcémie ont disparu. LOT_5 (D5.4) donne une classification non sourcée (2,65–2,99) et écrit « PTHrP bas ».

Question : Quelle recommandation européenne la plus récente (ESE, consensus hypercalcémie, ESMO pour l'hypercalcémie maligne) fixe la classification de l'hypercalcémie (seuils en mmol/L, calcium ionisé), l'hydratation, le bisphosphonate (acide zolédronique Zometa® 4 mg, pamidronate) et son adaptation rénale, la calcitonine (spécialité suisse disponible ?) et le dénosumab (Xgeva® 120 mg : indication suisse, usage hors étiquette, risque d'hypocalcémie si DFGe < 30) ? Quel profil PTH/PTHrP caractérise l'hypercalcémie humorale maligne ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-031 — Critique — LOT 3 · SSP G3

Emplacement : LOT_3_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste__export_GoogleDoc.html › Bloc 1 › 11. Prise en charge › B- Moyens et méthodes ; constats L3-M26, L3-M54, L3-M55, L3-M19, L3-M16

Contexte : L'Appel A recommande sans réserve régime hyposodé et thiazidique dans la résistance à l'AVP ; la Partie 4 prescrit < 6 g NaCl/j et Moduretic® (amiloride + 50 mg HCT) en 1re intention sous lithium ; l'amiloride n'a pas de dose ; seule une association Comilorid-Mepha® mite a été retrouvée. L'audit cite l'AIPS Quilonorm® retard.

Question : Quelle est la prise en charge recommandée (source européenne ou suisse la plus récente) de la résistance rénale à l'AVP induite par le lithium : amiloride (dose, spécialité suisse monocomposant ou association disponible), place des thiazidiques et des AINS, apport sodé, rythme de contrôle de la lithiémie ? Quelles spécialités d'amiloride (seul ou associé) sont commercialisées en Suisse en 2026 et Moduretic® existe-t-il encore ? Que dit l'AIPS de Quilonorm® retard sur le régime hyposodé et les diurétiques ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-039 — Critique — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10__export_GoogleDoc.html › D4.10 › point 10 « Arbre décisionnel » ; constats L4-M55, L4-M56, L4-M57, L4-L26, L4-L27, L4-L28, L4-L68, L4-M74, L4-M58, L4-L29

Contexte : Les doses d'hydrocortisone de la crise surrénalienne, du kit d'auto-injection, de la couverture périopératoire et le seuil au-delà duquel la fludrocortisone devient inutile ont disparu (V5 et V6). L'audit propose 100 mg IV puis 200 mg/24 h, kit 100 mg IM/SC, 100 mg à l'induction, ≥ 50 mg/24 h, d'après Husebye 2014, DGE et Bornstein 2016 (Endocrine Society).

Question : Quelle recommandation européenne la plus récente (ESE 2024/2025 sur l'insuffisance surrénalienne, consensus Husebye 2014) ou suisse (SSED) fixe : la dose d'hydrocortisone en crise (bolus, entretien, voie, enfant), le remplissage, la dose du kit d'urgence, la couverture périopératoire selon le type de chirurgie, les règles de maladie et le seuil d'hydrocortisone au-delà duquel la fludrocortisone est superflue ? Quelle présentation de Solu-Cortef® est disponible en Suisse et que dit son AIPS ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

A-046 — Critique — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7__export_GoogleDoc.html › D4.6 › point 11.B › ARNI ; constats L4-M38, L4-M39, L4-L20, L4-M40, L4-M44, L4-M45, L4-M54, L4-L48, L4-L49, L4-L50

Contexte : Le cours présente l'IEC comme alternative à l'ARNI sans le délai de 36 h, a perdu les seuils de kaliémie et de créatinine d'arrêt de l'ARM, fixe une hausse de créatinine tolérée à 30 % et une FC cible de 50–60 bpm, intègre l'omecamtiv mecarbil (demande EMA retirée en 2024). L'audit cite l'ESC 2021.

Question : Quelles règles de titration et de sécurité fixent la recommandation ESC la plus récente sur l'insuffisance cardiaque (2021, mise à jour 2023, et version 2025 si publiée) et les AIPS suisses d'Entresto®, de la spironolactone et de l'éplérénone : délai d'arrêt de l'IEC, dose initiale réduite, seuils de kaliémie et de créatinine pour réduire ou arrêter l'ARM, hausse de créatinine tolérée sous bloqueurs du SRAA, FC seuil pour l'ivabradine ? Quel est le statut Swissmedic de l'omecamtiv mecarbil ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-047 — Critique — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7__export_GoogleDoc.html › D4.7 › point 11.B › moyens non médicamenteux ; constats L4-M48, L4-L21, L4-M49, L4-L22, L3-M47, L4-M52, L4-M51, L4-L51

Contexte : Les seuils de DFGe pour la metformine et les conditions d'initiation de la finérénone ont disparu ; LOT_3 (D3.6 › 11.D) donne la dose de finérénone de la néphropathie diabétique au lieu de FINEARTS-HF (20/40 mg selon DFGe) ; Evrenzo® est présenté comme disponible sans statut Swissmedic ; le contraste iodé est dit contre-indiqué de façon absolue. L'audit cite KDIGO 2022 et ESUR 10.0 (2018).

Question : Que disent les AIPS suisses de la metformine (seuils de DFGe pour réduire ou arrêter) et de Kerendia® (indications suisses : néphropathie diabétique, insuffisance cardiaque à FEVG ≥ 40 % ; seuils de kaliémie et de DFGe d'initiation et d'arrêt ; doses) ? Evrenzo® (roxadustat) est-il autorisé en Suisse ? Quelle version la plus récente des recommandations ESUR fixe la prévention de la néphropathie aux produits de contraste iodés et le choix du gadolinium selon le DFGe ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-054 — Critique — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5__export_GoogleDoc.html › D5.4 › point 11.B › Hyperkaliémie menaçante › gluconate de calcium ; constats L5-M21, L5-M22, L5-L62, L5-M23, L5-L61

Contexte : Le cours donne 10 mL de gluconate de calcium 10 % (≈ 2,2 mmol), 10 UI d'insuline avec 100 g de glucose et attribue le sel calcique à Resonium® A (sel sodique). L'audit cite l'ERC 2021 relu via des synthèses secondaires (30 mL de gluconate 10 %, 25 g de glucose).

Question : Que recommande la version la plus récente de l'ERC (Guidelines 2025, circonstances particulières) et de la recommandation européenne ou suisse sur l'hyperkaliémie (ERA, protocole d'un hôpital universitaire suisse) : dose de gluconate ou chlorure de calcium, insuline-glucose (UI, grammes, surveillance glycémique), salbutamol, bicarbonate, résines (polystyrène sulfonate sodique ou calcique), patiromer (Veltassa®) et cyclosilicate de zirconium (Lokelma®) ? Quelles résines sont autorisées en Suisse ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-063 — Critique — LOT 6 · SSP G6

Emplacement :
LOT_6_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.5_a_DX.7__export_GoogleDoc.html › Appel B V5 Partie 3 › D6.5 › point 11.B › « Corticothérapie préalable anti-inflammatoire » ; constats L6-M04, L6-L34, L6-M11, L6-L16, L6-L41

Contexte : La V5 donne la dexaméthasone 10 mg sans rythme (lue 10 mg/j), la vancomycine sans dose, l'ampicilline IM devant un purpura fulminans ; la V6 n'a aucune molécule ni dose. L'audit cite la DGN/AWMF 2023 et l'ESCMID 2016 lue via résumé secondaire.

Question : Quelle est la recommandation la plus récente (ESCMID, DGN/AWMF 2023, SSI/guidelines.ch) pour la méningite bactérienne communautaire de l'adulte : délai, antibiothérapie probabiliste (ceftriaxone, amoxicilline/ampicilline selon âge et immunodépression, vancomycine : indication et dose), dexaméthasone (dose, rythme, durée, arrêt), conduite pré-hospitalière devant un purpura fulminans ; et pour l'encéphalite herpétique (aciclovir : dose et adaptation rénale selon l'AIPS) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-064 — Critique — LOT 6 · SSP G6

Emplacement :
LOT_6_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10__export_GoogleDoc.html › Appel B V5 Partie 4 › D6.10 › fenêtre 6.10 « Critères de gravité du paludisme (OMS) » ; constats L6-M05, L6-M17

Contexte : La V5 attribue à l'OMS une hyperparasitémie de 2 % ; la V6 n'a ni critères de gravité, ni dose d'artésunate, ni statut d'autorisation suisse, ni traitement de l'accès simple. L'audit cite l'OMS et l'EPAR Artesunate Amivas.

Question : Quels critères de gravité du paludisme à P. falciparum retiennent l'OMS et les recommandations européennes ou suisses pour voyageurs (seuil d'hyperparasitémie) ? L'artésunate IV est-il autorisé par Swissmedic ou disponible par importation (pharmacie de garde, réseau suisse), à quelle dose et quel suivi (hémolyse retardée) ? Quels traitements de l'accès simple (Riamet®, Malarone®) et quelles doses recommandent l'OFSP / Swiss TPH ? Combien de cas de paludisme importé déclare l'OFSP ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-071 — Critique — LOT 7 · SSP G7

Emplacement : LOT_7_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Point 11.B › fenêtre « Le dispositif et la pharmacologie répondent à des questions différentes » › dernier paragraphe ; constats L7-M06, L7-M07, L7-M08

Contexte : L'AIPS Epipen® (septembre 2025) et Adrenalin Sintetica® (novembre 2024) ont été lues ; il manque les doses pédiatriques, la prescription de deux auto-injecteurs, la demi-dose sous antidépresseurs tricycliques ou bêtabloquants, ainsi que le positionnement, l'oxygène, le remplissage et les traitements de 2e ligne (EAACI 2021, HUG 2025).

Question : Que recommandent la version la plus récente de l'EAACI sur l'anaphylaxie (2021 ou ultérieure), les recommandations suisses (SSAI, HUG) et l'ERC 2025 : dose d'adrénaline IM adulte et enfant, répétition, perfusion IV, positionnement, remplissage (volume), place et doses des antihistaminiques et corticoïdes, glucagon sous bêtabloquant, durée d'observation ? Quels auto-injecteurs sont autorisés en Suisse (Epipen®, Jext®, Emerade®, adrénaline nasale Neffy®/Eurneffy®) avec leurs doses par poids ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-073 — Critique — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 3 › fenêtre « Système de Stadification Suisse (Swiss Staging System) & Critère K+ » ; constats L8-M04, L8-M05, L8-M14, L8-M33, L8-M34, L8-L19, L8-M15

Contexte : Le cours retient une kaliémie > 8 mmol/L comme critère d'arrêt sur place et de non-ECLS, et cite aussi 12 mmol/L et « 8–12 mmol/L » ; l'audit médical (ERC 2025, ICAR 2023) retient le score HOPE ≥ 10 % et, à défaut, K+ < 7 mmol/L avec Tcc < 30 °C ; l'audit linguistique s'appuie sur l'ERC 2021 dont le texte primaire était inaccessible (HTTP 403) et signale des seuils suisses divergents (7, 8 ou 12 mmol/L).

Question : Quels seuils de kaliémie et quel rôle du score HOPE retiennent exactement l'ERC 2025 (Special Circumstances, section hypothermie accidentelle et avalanche), l'ICAR MedCom (2023 et ultérieur) et les protocoles suisses (SGNOR/SSMUS, Rega, centres ECLS de Berne, Lausanne, Zurich) pour décider d'un réchauffement par ECLS en hypothermie pure et après avalanche ? Comment ont évolué les seuils 12, 8 et 7 mmol/L entre ERC 2015, 2021 et 2025 ? Quel seuil de température ou de durée fonde l'arrêt de la réanimation après réchauffement ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-074 — Critique — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_B_V6_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 › fenêtre « Triage Avalanche ERC/ICAR » ; constats L8-M31, L8-M32, L8-L43, L8-L44, L8-L18

Contexte : La fenêtre de triage avalanche retient 35 minutes d'ensevelissement et arrête la réanimation à 45 minutes si les voies aériennes sont obstruées ; l'audit (ICAR 2023, ERC 2025 ; ERC 2021 inaccessible en texte primaire) retient 60 minutes et la présomption d'asphyxie avant ce délai.

Question : Quel algorithme de prise en charge sur place de la victime d'avalanche en arrêt cardiaque fixent l'ICAR MedCom 2023 (Pasquier et al.) et l'ERC 2025 : seuil de durée d'ensevelissement, rôle de la Tcc si la durée est inconnue, perméabilité des voies aériennes, insufflations initiales, critères de non-réanimation, orientation vers un centre ECLS ? La Rega ou la SSMUS appliquent-elles un algorithme suisse différent ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-075 — Critique — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 11.B › fenêtre « Médicaments de réanimation » ; constats L8-M08, L8-M09, L8-M10, L8-M11

Contexte : Le cours proscrit l'adrénaline sous 30 °C et ne dose pas l'amiodarone (règle ERC 2021) ; l'audit lit l'ERC 2025 : adrénaline 1 mg IV une seule fois sous 30 °C sauf ECPR imminente, amiodarone 300 mg en dose de charge, intervalle de 6–10 min entre 30 et 35 °C. « Adrenalin® » n'est pas une spécialité suisse vérifiée ; l'amiodarone n'a pas de spécialité.

Question : Quelles règles pharmacologiques de la RCP en hypothermie (adrénaline, amiodarone, nombre de chocs) retient l'ERC 2025 par tranche de température, et en quoi diffèrent-elles de l'ERC 2021 ? Quelles spécialités suisses d'adrénaline et d'amiodarone injectables (Adrenalin Sintetica®, Cordarone®…) sont autorisées et quelle dose IV/IO donne leur AIPS en réanimation ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-076 — Critique — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 3 › fenêtre 3.1 › tableau Swiss Staging › ligne HT IV ; constats L8-M06, L8-M07, L8-L20, L8-M12, L8-M13, L8-M39, L8-M41, L8-L51

Contexte : Le cours utilise la stadification suisse ancienne (frisson, « < 28 °C si FV ») ; l'arbre omet les facteurs de risque d'ACR imminent et subordonne le transfert à la kaliémie ; les seuils 32 °C et 30 °C diffèrent entre fichiers. L'audit cite le système suisse révisé (Musi 2021) repris par l'ERC 2025 (AVPU, FC < 45/min, PAS < 90 mmHg, ETCO2 < 1,3 kPa, centre ECLS atteignable en 6 h).

Question : Quel système de stadification de l'hypothermie accidentelle (système suisse révisé 2021, ICAR, ERC 2025) et quels critères d'orientation directe vers un centre ECLS/ECPR (facteurs de risque d'arrêt, délai de transport, indications d'ECLS chez le patient non en arrêt) sont en vigueur en 2026 ? Comment s'appliquent-ils en Suisse (protocole Rega, centres ECLS) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P01 — 17 questions : A-007, A-021, A-026, A-028, A-029, A-031, A-039, A-046, A-047, A-054, A-063, A-064, A-071, A-073, A-074, A-075, A-076